

Post 36-godzinny po 50-tce: fazy 0–36 h, efekty, ryzyko



Post 36-godzinny zmienia dostępność paliwa: organizm stopniowo zużywa glikogen, zwiększa uwalnianie kwasów tłuszczowych i produkuje więcej ketonów. Nie jest to jednak zegar działający identycznie u każdego. Poniżej oddzielam dobrze opisane zmiany metaboliczne od twierdzeń, których nie potwierdzono u ludzi — szczególnie dokładnej godziny autofagii, „resetu” insuliny i ochrony mięśni przez hormon wzrostu.

Szybka odpowiedź

W ciągu 36 godzin bez jedzenia zwykle spada insulina, rośnie wykorzystanie tłuszczu i zwiększa się stężenie ketonów. Tempo zmian jest indywidualne. Nie znamy jednej godziny „włączenia” autofagii, a wzrost hormonu wzrostu nie oznacza ochrony mięśni. Przy cukrzycy, lekach, chorobie nerek, niedowadze lub zaburzeniach odżywiania taki post wymaga konsultacji.

Kluczowe wnioski

- Badania postu naprzemiennego i ograniczonych okien żywieniowych nie są automatycznie badaniami jednorazowego postu 36-godzinnego.
- Ketony rosną wraz z czasem bez jedzenia, ale ich poziom zależy od wcześniejszej diety, aktywności i metabolizmu.
- Nie ustalono u ludzi uniwersalnego progu godzinowego dla autofagii.
- Hormon wzrostu może wzrastać, lecz bez aminokwasów synteza białek mięśniowych nie działa jak po posiłku i treningu.
- Przy lekach obniżających glukozę lub ciśnienie post może wymagać zmiany dawkowania wyłącznie przez lekarza.

Co można ostrożnie powiedzieć o fazach postu 0–36 godzin

Czas od posiłku	Dominująca zmiana	Czego nie da się obiecać
0–12 h	Wykorzystanie energii z ostatniego posiłku i glikogenu	Nie istnieje jedna godzina identyczna dla każdego
12–24 h	Spadek insuliny i rosnący udział kwasów tłuszczowych oraz ketonów	To nie jest „reset” metabolizmu ani leczenie insulinooporności
24–36 h	Dalszy wzrost ketonów; odpowiedź zależy od diety, aktywności i zdrowia	Nie znamy dokładnej godziny uruchomienia autofagii u człowieka
Po przerwaniu	Powrót podaży energii, płynów i białka	Jednorazowy post nie daje trwałego efektu bez zmiany nawyków

Co tak właściwie dzieje się z ciałem przez te 36 godzin?

Kiedy przestajesz jeść, twoje ciało nie wchodzi od razu w tryb paniki. Przez pierwsze 6–8 godzin po ostatnim posiłku organizm spokojnie spala glukozę z glikogenu wątrobowego. To zupełnie normalna praca na co dzień – tak działasz przez całą noc podczas snu. Gdyby samo niespanie i niejedzenie przez 8 godzin było czymś niezwykłym, nie przeżyłby żaden człowiek. Problem zaczyna się i – paradoksalnie – zaciekawia, gdy głodzenie trwa dłużej.

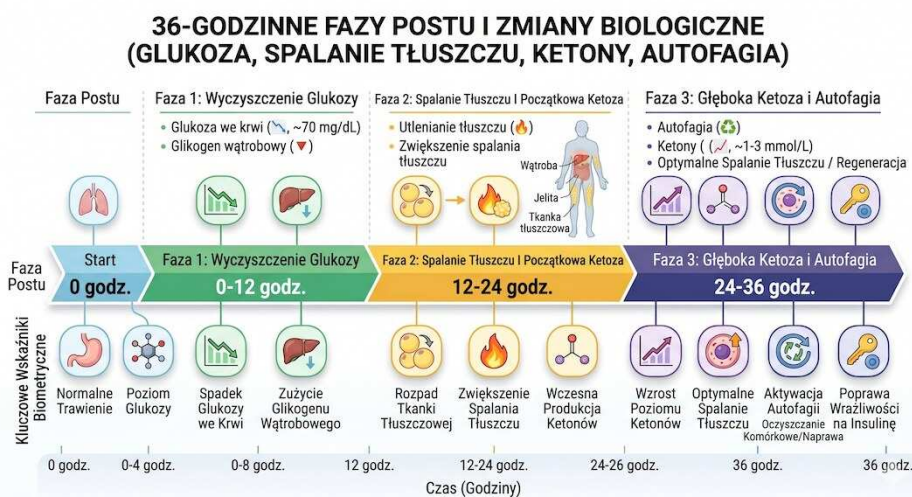
Między mniej więcej 12. a 24. godziną udział glikogenu wątrobowego maleje, a organizm coraz silniej korzysta z kwasów tłuszczowych. Nie jest to przełącznik działający o tej samej godzinie u każdego: wpływają na niego wcześniejsze posiłki, zapasy glikogenu, aktywność i indywidualna odpowiedź metaboliczna.

Wraz z przedłużaniem postu wątroba zwiększa produkcję ketonów. W jednym badaniu konkretnego protokołu dwa 36-godzinne posty tygodniowo wiązały się z wyższym beta-hydroksymaślanem, ale wyniku nie należy nazywać uniwersalną „zmianą paliwa” ani przenosić na każdą osobę.

Po 24–36 godzinach insulina jest zwykle niższa, a ketony wyższe niż po zwykłej przerwie nocnej. Nie oznacza to najniższego możliwego poziomu insuliny ani „głębszego” stanu niż każda dieta niskowęglowodanowa. Dane o autofagii i hormonie wzrostu wymagają osobnego omówienia i nie uzasadniają obietnicy odmładzania.

Warto podkreślić jedno: przegląd systematyczny opublikowany przez Endocrine Reviews w 2025 roku (Oxford Academic), obejmujący randomizowane badania kliniczne z okresu do października 2024 roku, potwierdza, że przerywany post i post alternatywny wywołują realną, mierzalną i powtarzalną odpowiedź metaboliczną u ludzi. To nie są obserwacje na myśzkiej przeniesionych siłą do artykułów popularno-naukowych. To wyniki kontrolowanych prób klinicznych na prawdziwych ludziach. Co ważne, ci sami autorzy zastrzegają, że skala tych efektów i ich długoterminowe utrzymanie wymagają dalszych badań. Uczciwa nauka tak właśnie wygląda.

Co to znaczy w praktyce Kiedy przestajesz jeść, twoje ciało nie wchodzi od razu w tryb paniki.



Oś czasu metabolizmu podczas 36-godzinnej przerwy – od spalania glukozy do produkcji ketonów i uruchomienia autofagii.

Czy insulinooporność i glukoza naprawdę się resetują?

Określenie „reset insuliny” jest nieprecyzyjne. Niektóre badania przerywanego postu pokazują poprawę HOMA-IR, ale efekt bywa związany z mniejszą podażą energii, utratą masy i zmianą rytmu posiłków. HOMA-IR jest markerem, nie dowodem wyleczenia insulinooporności po jednej 36-godzinnej przerwie.

Przeglądy prób klinicznych wskazują, że różne formy postu mogą poprawiać niektóre markery metaboliczne, jednak wyniki są niejednorodne. Porównanie z ciągłym ograniczeniem kalorii często nie pokazuje wyraźnej przewagi. To ważne: wykonalność i utrzymanie sposobu żywienia są istotniejsze niż efekt jednego postu.

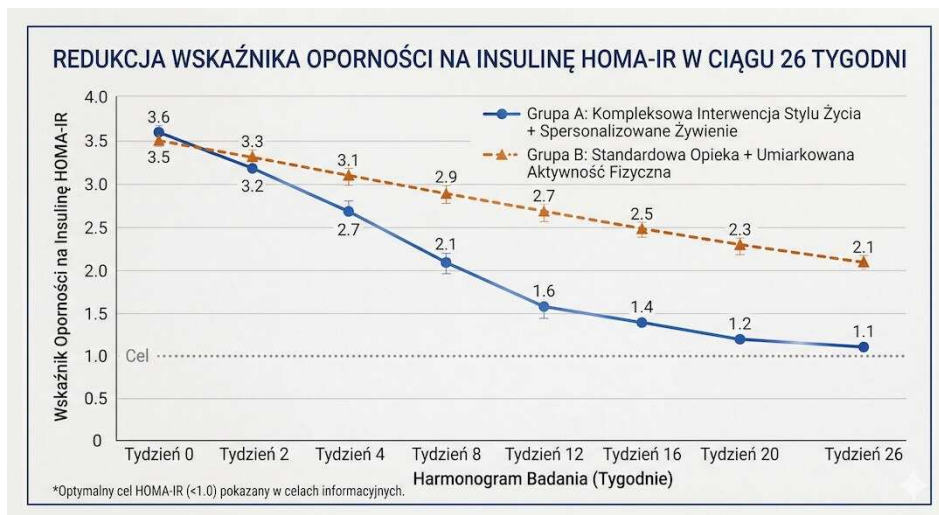
W badaniu Horne i współpracowników oceniano powtarzane 24-godzinne posty, a nie pojedynczy post 36-godzinny. Wynik może pomóc zrozumieć mechanizmy, ale nie uprawnia do polecenia postu zamiast metforminy ani do samodzielnej zmiany leczenia prediabetes lub cukrzycy.

Niższa insulina podczas postu ułatwia uwalnianie kwasów tłuszczowych, ale metafora „restartu receptorów”

upraszcza złożoną biologię. Wrażliwość insulinowa zależy od tkanki, pory pomiaru, bilansu energii, aktywności i masy ciała. Krótkotrwały wynik laboratoryjny nie jest równoznaczny z trwałym leczeniem.

Jeden ważny niuans, który uczciwie trzeba wymienić: większość badań dotyczy postów 24-godzinnych lub naprzemiennych co drugi dzień. Ekstrapolowanie wyników bezpośrednio na 36-godzinny post ma sens biologicznie, bo efekty metaboliczne są silniejsze przy dłuższym oknie głodzenia, ale brakuje wystarczającej liczby randomizowanych badań klinicznych dedykowanych dokładnie 36 godzinom jako oddzielnej interwencji. To uczciwe ograniczenie, o którym autorzy Endocrine Reviews 2025 wyraźnie piszą, nie zamiatając go pod dywan.

Co to znaczy w praktyce Określenie „reset insuliny” jest nieprecyzyjne. Niektóre badania przerywanego postu pokazują poprawę HOMA-IR, ale efekt bywa związany z mniejszą podażą energii, utratą masy i zmianą rytmu posiłków. HOMA-IR jest markerem, nie dowodem wyleczenia insulinooporności po jednej 36-godzinnej przerwie.



Redukcja insulinooporności (HOMA-IR) po 26 tygodniach intermittent fasting – dane z RCT Horne et al. 2024.

Czy hormon wzrostu naprawdę wzrasta o 1300%?

Ta liczba pojawia się dosłownie wszędzie. 1300% wzrostu HGH przy poście – brzmi jak reklama dożylniej terapii hormonalnej w klinice medycyny estetycznej, nie jak suchy wynik badania naukowego. Prawda jest bardziej skomplikowana i paradoksalnie nadal imponująca – ale wymaga kontekstu, bo bez niego jest po prostu mylącym clickbaitem.

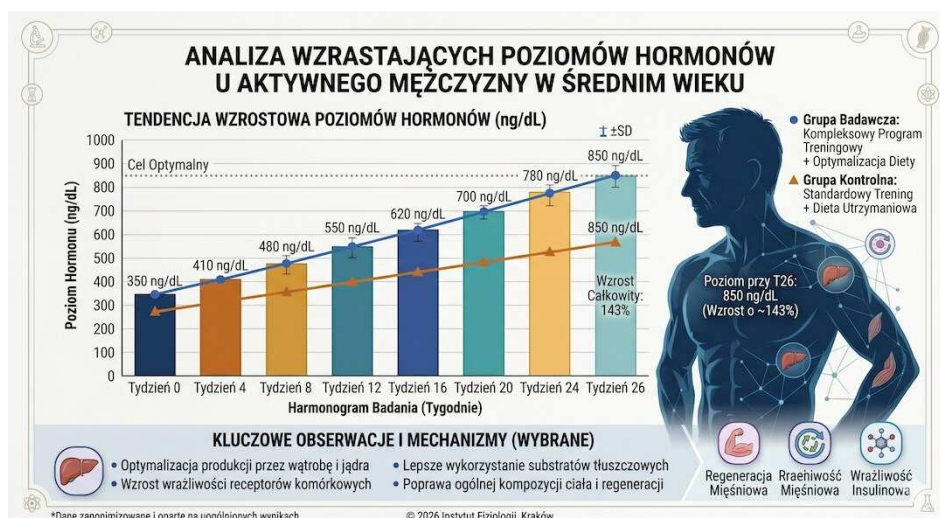
Cytowana liczba 1300% pochodzi z klasycznego badania Ho i współpracowników z 1988 roku opublikowanego w New England Journal of Medicine. Autorzy mierzyli pulsacyjne wydzielanie HGH u mężczyzn podczas 5-dniowego postu i wykazali wielokrotny wzrost dobowego wyrzutu hormonu wzrostu. Liczba 1300% pojawia się w niektórych interpretacjach jako skumulowany efekt u kobiet podczas wielodniowego postu. Dotyczyła dłuższego głodzenia i była mierzona całłościowo przez kilka dób – nie jednorazowego 36-godzinnego postu u zdrowego faceta w średnim wieku.

Co mówią nowsze dane? Horne i współpracownicy (Frontiers in Endocrinology, luty 2025) opublikowali wtórną analizę randomizowanego badania kontrolowanego, która wykazała, że 24-godzinny post na wodzie znacznie zwiększa stężenie HGH we krwi, a efekt ten był niezależny od utraty masy ciała. Równolegle, analiza z NPJ Metabolic Health and Disease z 2024 roku potwierdziła, że wyższe wyjściowe stężenie HGH u uczestników badania korelowało z lepszymi efektami metabolicznymi intermittent fasting – co sugeruje, że HGH jest aktywnym mediatorem efektów postu, a nie tylko epifenomenem. Dla mężczyzny po pięćdziesiątce, którego naturalny poziom HGH spada o kilka procent rocznie, to całkiem interesująca dynamika. Więcej o hormonach po 50-tce znajdziesz w naszym materiale o [testosteronie po 50 i naturalnym wsparciu hormonalnym](#).

Hormon wzrostu podczas głodzenia pomaga regulować wykorzystanie paliw, lecz nie działa jak anaboliczna ochrona mięśni. Do budowy białek mięśniowych potrzebne są aminokwasy i bodziec treningowy. Wzrost HGH nie dowodzi, że 36-godzinny post zabezpiecza mięśnie osoby po 50-tce.

Czy to oznacza, że post zastąpi terapię hormonem wzrostu? Absolutnie nie. Wartości HGH osiągane podczas postu są znacznie niższe niż stosowane w terapii zastępczej i mają inny profil czasowy wydzielania. Ale czy to fizjologicznie korzystny efekt, potwierdzony w kontrolowanych warunkach? Tak – i to jest wystarczające, żeby brać go poważnie w kontekście stylu życia.

Co to znaczy w praktyce Ta liczba pojawia się dosłownie wszędzie.



Wzrost HGH podczas postu – efekt niezależny od utraty wagi (Horne et al. 2025, Frontiers in Endocrinology).

Autofagia – czy komórki naprawdę sprzątają się podczas postu?

Autofagia jest stałym procesem porządkowania składników komórki, regulowanym między innymi przez dostępność energii. U ludzi nie ma zwalidowanego zegara mówiącego, że uruchamia się dokładnie po 18, 24 lub 36 godzinach. Wyniki z tkanek zwierzęcych i pojedynczych markerów nie pozwalają obiecać „oczyszczania komórek”.

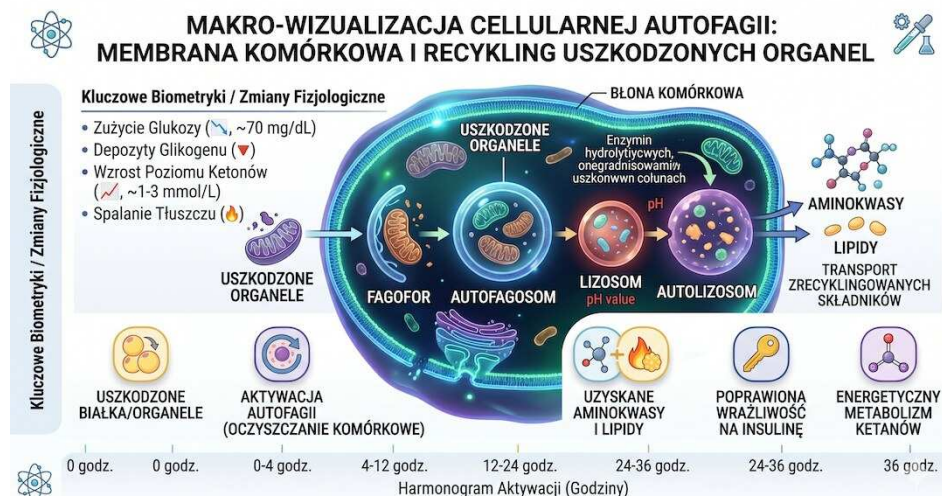
Do maja 2025 roku nie mieliśmy bezpośredniego dowodu, że post przerywany zwiększa autofagię u ludzi mierzoną fizjologicznie, a nie tylko na podstawie pośrednich markerów genowych lub białkowych. Wszystkie wcześniejsze badania opierały się albo na modelach mysich, albo mierzyły poziomy białek regulujących autofagię (LC3, p62, Beclin1) jako proxy – nie rzeczywisty przepływ autofagiczny. To ważne rozróżnienie: marker może wzrastać lub spadać niezależnie od faktycznej aktywności procesu.

To właśnie zmieniło przełomowe badanie Bensalema i współpracowników opublikowane w Journal of Physiology w maju 2025 roku. W randomizowanym badaniu kontrolowanym z udziałem 121 osób z otyłością, po 6 miesiącach protokołu intermittent fasting z ograniczeniem czasowym, badacze zmierzili autofagiczny strumień w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej za pomocą fizjologicznie relewantnej metody z użyciem chlorochiny. Wynik: istotny wzrost autofagicznego strumienia w grupie iTRE w porównaniu do grupy standardowej opieki po 6 miesiącach. To pierwsze tego typu potwierdzenie u żywych ludzi – nie w mysim modelu, nie in vitro, ale u prawdziwych uczestników badania klinicznego.

Jest jednak kilka ważnych zastrzeżeń, których nie wolno przemilczeć. Po pierwsze: to badanie eksploracyjne – oznacza to, że wymaga replikacji w większych i bardziej zróżnicowanych próbach. Po drugie: efekt był widoczny po 6 miesiącach protokołu, a nie po jednorazowym 36-godzinym poście. Badacze sami zaznaczają w artykule, że potrzeba więcej danych, żeby wyciągać kliniczne wnioski. Po trzecie: badanie dotyczyło osób z otyłością, więc wyniki niekoniecznie mają takie samo przełożenie na osoby ze zdrową masą ciała. Odrębne badanie z PubMed, opublikowane przez Rollanda i współpracowników w 2018 roku, analizowało wpływ 36-godzinnego postu na markery autofagii w tkance mięśniowej u ludzi. Wyniki były skromne: efekt był wyraźniejszy u osób nieaktywnych fizycznie niż wytrenowanych, co sugeruje, że trening może częściowo zastępować lub równoważyć efekt postu na autofagię mięśniową.

Nie bez znaczenia jest kontekst nowotworowy. Przegląd systematyczny opublikowany w PMC w maju 2025 roku wskazuje, że post przerywany może zarówno hamować wzrost nowotworów poprzez autofagię jako mechanizm supresora guza, jak i w pewnych warunkach wspierać przeżycie komórek nowotworowych jako mechanizm adaptacyjny pod presją metaboliczną. To podwójna i zależna od kontekstu rola autofagii w onkologii. Jest to powód, dla którego osoby w trakcie leczenia onkologicznego powinny jakiegokolwiek protokoły postne bezwzględnie konsultować z prowadzącym onkologiem. Więcej o [badaniach profilaktycznych po 50-tce i sygnałach ostrzegawczych](#) znajdziesz na naszym portalu.

Co to znaczy w praktyce Autofagia jest stałym procesem porządkowania składników komórki, regulowanym między innymi przez dostępność energii. U ludzi nie ma zwalidowanego zegara mówiącego, że uruchamia się dokładnie po 18, 24 lub 36 godzinach. Wyniki z tkanek zwierzęcych i pojedynczych markerów nie pozwalają obiecać „oczyszczania komórek”.



Autofagia: komórkowe sprzątanie aktywowane przez post – po raz pierwszy bezpośrednio potwierdzone u ludzi w maju 2025 roku.

Czy 36-godzinny post niszczy mięśnie?

To pytanie boli każdego, kto ciężko pracował na swoją masę mięśniową – zwłaszcza po pięćdziesiątce, gdy mięśnie buduje się wolniej i traci szybciej niż w dwudziestych latach. Odpowiedź naukowa jest precyzyjna: przy jednorazowym, dobrze zaplanowanym poście 36-godzinnym ryzyko klinicznie istotnej utraty mięśni jest niskie – ale nie zerowe i zależy od kontekstu, nawodnienia, podaży białka w dniach jedzenia i poziomu aktywności fizycznej.

Najnowsze twarde dane przynosi badanie Naegela i współpracowników opublikowane w Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle w kwietniu 2025 roku. To badanie prospektywne z udziałem 32 osób, w tym połowy powyżej 50. roku życia, analizowało wpływ 12-dniowego postu z bardzo niską podażą kalorii (250 kcal/dzień) na strukturę, skład i funkcję mięśni przy użyciu zaawansowanej techniki MRI i spektroskopii rezonansowej. Przy średniej utracie masy ciała 5,9 kg zmiana objętości mięśnia łydki wyniosła zaledwie 5,4% – i była tłumaczona głównie utratą glikogenu i wody związanej z glikogenem, a nie faktycznym katabolizmem białek kontraktylnych. Siła mięśniowa mierzona maksymalnym skurczem dowolnym pozostała zachowana w obu grupach wiekowych i obydwu płciach. Dodatkowy wniosek: miesiąc po zakończeniu postu parametry mięśniowe wróciły do wartości wyjściowych. Mięśnie nie zostały trwale zniszczone.

Jeśli 12-dniowy post z minimalną podażą kalorii nie zniszczył mięśni w sposób klinicznie istotny, to 36-godzinny post w normalnych warunkach tygodniowych jest znacznie mniejszym obciążeniem. Badanie Borera i współpracowników (PMC, 2024) obserwowało uczestników przez 82 tygodnie przy dwukrotnych 36-godzinnych postach tygodniowo i nie stwierdzono spowolnienia spoczynkowej przemiany materii ani istotnej utraty masy mięśniowej. To ważny wynik, bo jedna z najczęstszych obaw dotyczących długich postów to właśnie mechanizm obronny metabolizmu – spowolnienie podstawowej przemiany materii jako odpowiedź na chroniczne głodzenie. Przy protokole 36h dwa razy w tygodniu efekt ten nie wystąpił.

Kluczowe zmienne chroniące mięśnie podczas postu 36-godzinnego to trzy filary: po pierwsze, odpowiednia podaż białka w dniach jedzenia – minimum 1,6 do 2,0 gramów na kilogram masy ciała, najlepiej rozłożona równomiernie na posiłki. Po drugie, trening oporowy, który wysyła sygnał anaboliczny do komórek mięśniowych i utrzymuje syntezę białek na odpowiednim poziomie. Po trzecie, właściwe nawodnienie i uzupełnianie elektrolitów podczas samego postu – bez tego ryzyko skurczów i osłabienia mięśni znacznie rośnie. Jeśli pomijasz któryś z tych elementów, post rzeczywiście może zaczynać jadać mięśnie zamiast tłuszczu trzewnego. Więcej o ochronie mięśni po pięćdziesiątce przeczytasz w naszym materiale o [białku i kreatynie po 50-tce dla ochrony mięśni](#).

Warto dodać, że HGH wzrastający podczas postu działa ochronnie na masę mięśniową – hamuje rozpad białek kontraktylnych i wspomaga mobilizację tłuszczu jako paliwa alternatywnego. To ewolucyjne zabezpieczenie: kiedy praludzkie organizmy przez kilka dni nie miały dostępu do pożywienia, musiały

zachować siłę mięśniową do polowania i ucieczki. Ewolucja zadbała o to, żeby głód nie równał się automatycznej utracie mięśni. Jeden mechanizm więcej działający na twoją korzyść podczas postu – o ile robisz to z głową.

Co to znaczy w praktyce To pytanie boli każdego, kto ciężko pracował na swoją masę mięśniową – zwłaszcza po pięćdziesiątce, gdy mięśnie buduje się wolniej i traci szybciej niż w dwudziestych latach.



Trening oporowy i odpowiednia podaż białka w dniach jedzenia chronią mięśnie podczas protokołów postnych.

Dla kogo post 36-godzinny jest ryzykowny lub zakazany?

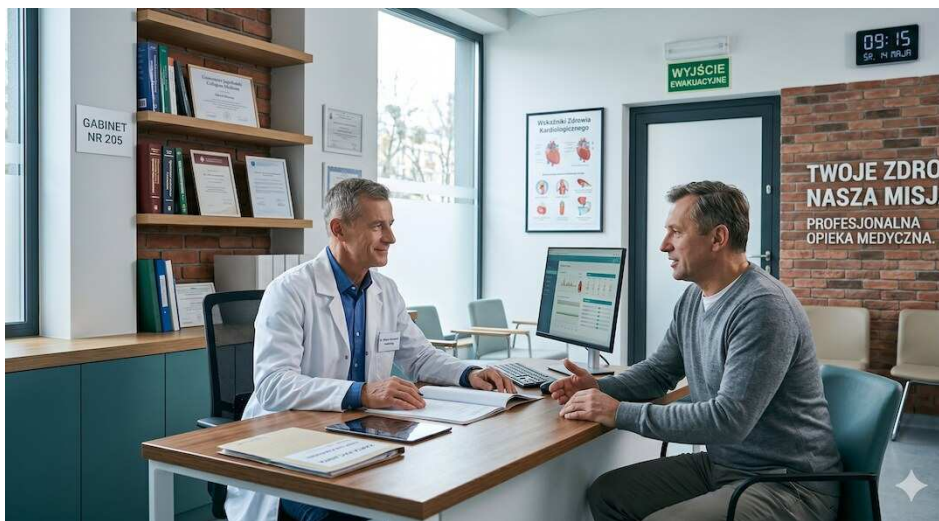
Zanim przejdziesz do praktyki, musisz wiedzieć, że post 36-godzinny – jak każda potężna interwencja – ma swoje wyraźne przeciwwskazania. I nie chodzi tu o to, żeby straszyć, ale o to, że te ograniczenia są poparte konkretnymi danymi klinicznymi, a nie ostrożnością typową dla etykiety na opakowaniu leków.

Twarde przeciwwskazanie numer jeden: cukrzyca typu 1. Kliniczne badanie Mosera i współpracowników opublikowane w *Frontiers in Endocrinology* w 2021 roku przeprowadzone metodą crossover na dorosłych z cukrzycą typu 1 wykazało, że nawet jeden 36-godzinny post niesie istotne i trudno przewidywalne ryzyko hipoglikemii i zaburzeń glikemicznych w tej grupie, mimo intensywnego monitorowania stężenia glukozy. Niestabilność metaboliczna podczas postu u tych pacjentów jest zbyt duża, żeby bezpiecznie zalecać ten protokół bez bezpośredniego nadzoru diabetologa i specjalistycznego protokołu dostosowania insulinoterapii.

Lista osób, które powinny unikać lub bardzo ostrożnie podchodzić do postu 36-godzinnego bez konsultacji lekarskiej, jest konkretna: kobiety w ciąży i karmiące piersią (zapotrzebowanie kaloryczne i mikroodżywcze jest zbyt wysokie), osoby z potwierdzoną historią zaburzeń odżywiania – anoreksja, bulimia, ortoreksja – bo post może być potencjalnym wyzwaczem nawrotu, osoby przyjmujące leki hipoglikemizujące inne niż metformina, osoby z aktywną chorobą nerek lub wątroby, osoby po poważnych zabiegach chirurgicznych w ostatnich 3 miesiącach oraz seniorzy powyżej 70. roku życia bez konsultacji lekarskiej i dobrego stanu odżywienia wyjściowego. W tej ostatniej grupie ryzyko sarkopenii i niedoborów elektrolitowych jest zbyt wysokie, żeby eksperymentować bez nadzoru specjalisty.

Nawet u pozornie zdrowej osoby tolerancja postu jest indywidualna. Silne zawroty głowy, omdlenie, splątanie, utrzymujące się kołatanie serca lub objawy hipoglikemii nie są zwykłą „adaptacją”. Nie ma też podstaw, by każdemu po 24 godzinach zalecać samodzielne przyjmowanie potasu, który może być niebezpieczny przy chorobach nerek i części leków.

Co to znaczy w praktyce Zanim przejdziesz do praktyki, musisz wiedzieć, że post 36-godzinny – jak każda potężna interwencja – ma swoje wyraźne przeciwwskazania.



Przed wdrożeniem 36-godzinnego postu warto wykluczyć przeciwwskazania – szczególnie przy cukrzycy i lekach.

Więc czy to naprawdę najlepsza medycyna świata?

Werdykt jest skromniejszy niż internetowe hasła: 36-godzinny post zmienia metabolizm na czas niejedzenia, ale nie jest lekiem i nie ma udowodnionej przewagi dla długoterminowego zdrowia nad innymi wykonalnymi metodami kontroli energii. Im więcej chorób i leków, tym mniej miejsca na samodzielny eksperyment.

Badania potwierdzają, że różne protokoły postu mogą podnosić ketony i zmieniać niektóre markery metaboliczne. Nie wszystkie dotyczą dokładnie 36 godzin, a część wyników wynika z utraty masy lub mniejszej podaży energii. Autofagia u ludzi ma ograniczone dane, a wzrost HGH nie dowodzi anabolizmu ani ochrony mięśni bez aminokwasów.

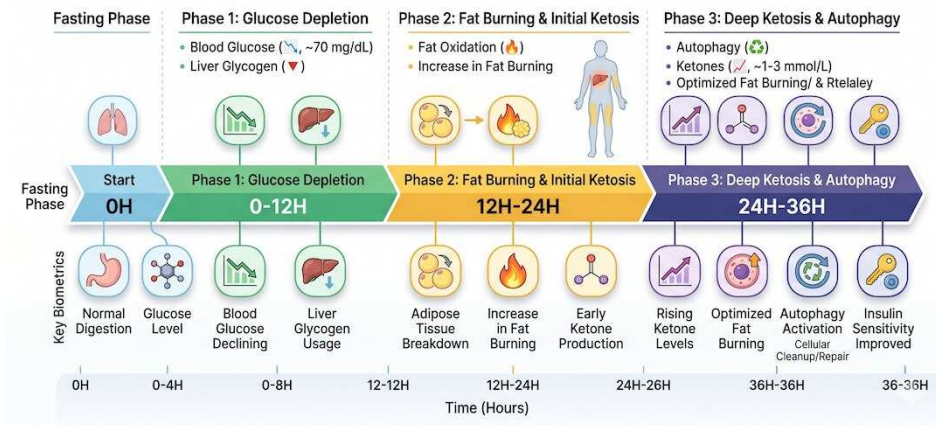
A co nie jest potwierdzone lub jest poważnie ograniczone w dostępnych danych? Brak wieloletnich randomizowanych badań klinicznych dedykowanych dokładnie 36-godzinnemu postowi jako oddzielnej interwencji u ogólnej populacji. Brak danych o utrzymaniu efektów przez 3–5 lat. Autofagia u ludzi potwierdzona eksploracyjnie po 6 miesiącach iTRE – to odkrycie świeże, jedno badanie, wymaga replikacji. I przede wszystkim: nie istnieje żadne badanie head-to-head porównujące post 36-godzinny z lekami kardiologicznymi, hipoglikemizującymi, statynami lub onkologicznymi. Przeglądowy artykuł w *Endocrine Reviews* z 2025 roku wprost stwierdza, że potrzeba więcej prospektywnych, kontrolowanych badań, zanim przerywany post będzie mógł być klinicznie rekomendowany jako terapia w konkretnych wskazaniach.

Post nie leczy zakażeń, miażdżycy ani cukrzycy i nie zastępuje farmakoterapii. Może być dla części osób sposobem organizacji jedzenia, ale jego wartość zależy od bezpieczeństwa, wykonalności i długoterminowego wyniku. Najczęstsze obietnice zestawiamy osobno z badaniami w analizie [postu 36-godzinnego: korzyści, ryzyko i granice dowodów](#). Dla zdrowia metabolicznego pierwszeństwo mają regularny ruch, sen, jakość diety oraz leczenie zalecone przez lekarza.

Jeśli celem jest poprawa zdrowia metabolicznego, pierwszeństwo mają ruch, trening oporowy, sen, jakość diety i leczenie zalecone przez lekarza. Post może być dla części osób akceptowalnym sposobem organizacji jedzenia, ale nie powinien być domyślną receptą dla mężczyzny po 50-tce z nadwagą, wysokim LDL lub podwyższoną insuliną.

Co to znaczy w praktyce Werdykt jest skromniejszy niż internetowe hasła: 36-godzinny post zmienia metabolizm na czas niejedzenia, ale nie jest lekiem i nie ma udowodnionej przewagi dla długoterminowego zdrowia nad innymi wykonalnymi metodami kontroli energii. Im więcej chorób i leków, tym mniej miejsca na samodzielny eksperyment.

36-HOUR FASTING PHASES & BIOLOGICAL CHANGES (GLUCOSE, FAT BURNING, KETONES, AUTOPHAGY)



Post 36-godzinny wywołuje mierzalne zmiany, lecz ich znaczenie kliniczne zależy od protokołu, zdrowia i długoterminowych nawyków.

Najczęściej zadawane pytania

Po ilu godzinach postu zaczyna się autofagia u ludzi?

Precyzyjne określenie progu aktywacji autofagii u ludzi jest trudne – badania na modelach zwierzęcych sugerują aktywację po 12–24 godzinach głodzenia, ale u ludzi bezpośrednie potwierdzenie wzrostu autofagicznego strumienia pochodzi z badania Journal of Physiology (maj 2025), gdzie efekt był widoczny po 6 miesiącach protokołu iTRE, nie po jednorazowym poście. Nie ma danych pozwalających wskazać dokładną godzinę włączenia autofagii u człowieka.

Czy post 36-godzinny jest bezpieczny dla osoby po 50-tce?

Dla zdrowej osoby po 50-tce bez cukrzycy, choroby nerek, zaburzeń odżywiania i bez leków hipoglikemizujących – jest ogólnie bezpieczny. Badanie Cell Metabolism (Stekovic et al. 2019) stosowało ADF przez ponad 6 miesięcy bez efektów niepożądanych u zdrowych, nieotyłych dorosłych w średnim wieku. Kluczowe są nawodnienie i elektrolity. Zalecana konsultacja lekarska przed wdrożeniem, szczególnie przy jakichkolwiek chorobach przewlekłych.

Czy podczas 36-godzinnego postu mogę ćwiczyć?

Tak, umiarkowana aktywność aerobowa jest możliwa i może nasilać produkcję ketonów. Badanie Deru et al. (Medicine and Science in Sports and Exercise, 2021) wykazało, że ćwiczenia podczas 36-godzinnego postu zwiększają stężenie beta-hydroksymaślanu. Intensywny trening siłowy lepiej jednak planować na dzień po poście lub w dniu jedzenia, żeby zapewnić substrat energetyczny i aminokwasy do regeneracji tkanki mięśniowej.

Ile razy w tygodniu robić 36-godzinny post dla zdrowia?

Nie ustalono uniwersalnej częstotliwości zapewniającej korzyść. Badania stosują różne schematy, lecz nie tworzą zaleceń dla każdej osoby po 50-tce. Przy chorobach, lekach, małej masie ciała lub problemach z jedzeniem decyzję trzeba omówić z lekarzem.

Czy post 36-godzinny pomaga na wysoki cholesterol?

Niektóre protokoły postu wiązały się ze zmianą lipidów, ale wyniki nie są jednolite i zależą od masy ciała oraz diety. Post nie zastępuje oceny całego ryzyka sercowo-naczyniowego ani leczenia zaleconego przy wysokim LDL.

Dawkę białka, najlepsze źródła, odżywki i strategie ochrony mięśni zebraliśmy w [Centrum Białka po 50-tce](#).

Udostępnij artykuł

Wyślij ten materiał przyjacielowi albo opublikuj u siebie. Jednym kliknięciem podasz aktualny link i tytuł artykułu.

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Mail

Kopiuje link

Źródła

1. [Stekovic et al. – Alternate Day Fasting Improves Physiological and Molecular Markers of Aging in Healthy Non-obese Humans \(Cell Metabolism, 2019\)](#)
2. [Bensalem et al. – Intermittent time-restricted eating increases autophagic flux in humans: exploratory analysis \(Journal of Physiology, maj 2025\)](#)
3. [Borer et al. – Twice-Weekly 36-Hour Intermittent Fasting Quadruples Beta-Hydroxybutyrate and Maintains Weight Loss \(PMC, 2024\)](#)
4. [Horne et al. – Insulin Resistance Reduction, Intermittent Fasting and Human Growth Hormone \(NPJ Metabolic Health and Disease, 2024\)](#)
5. [Horne et al. – Weight Loss-Independent Changes in HGH During Water-Only Fasting \(Frontiers in Endocrinology, 2025\)](#)
6. [Naegel et al. – Impact of Long-Term Fasting on Skeletal Muscle Structure, Metabolism and Function \(Journal of Cachexia Sarcopenia and Muscle, 2025\)](#)
7. [Endocrine Reviews 2025 – Critical Assessment of Fasting to Promote Metabolic Health and Longevity \(Oxford Academic\)](#)
8. [PMC 2025 – Role of Intermittent Fasting in Activation of Autophagy in Context of Cancer Diseases](#)
9. [Rolland et al. – Training State and Skeletal Muscle Autophagy in Response to 36h Fasting \(PubMed, 2018\)](#)
10. [Moser et al. – Impact of a Single 36 Hours Prolonged Fasting Period in Adults With Type 1 Diabetes \(Frontiers in Endocrinology, 2021\)](#)

Uwaga: Artykuł ma charakter informacyjny i edukacyjny. Nie zastępuje konsultacji lekarskiej, diagnozy ani leczenia.